

1. OBJETIVO.

Identificar infecciones desde el punto de vista epidemiológico, los sitios de infección, los dispositivos y procedimientos; con el fin de prevenir la incidencia de infecciones.

2. ALCANCE.

Inicia cuando el auxiliar de epidemiológica identifica factores de riesgo de los pacientes desde el momento que ingresa y termina cuando a través del "Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, (CODECIAAS)", se analiza en conjunto las incidencias y se comprometen los integrantes a realizar acciones de prevención.

3. DEFINICIONES.

IAAS: Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), se definen de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el proceso de asistencia en un hospital o Centro Sanitario, que no estaba presente, ni en período de incubación al momento de su ingreso y que pueden inclusive llegar a manifestarse después del alta del paciente.

CODECIAAS: Son las siglas del Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.

4. RESPONSABILIDADES.

Actualización: Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UEH).

Ejecución: Auxiliar de Epidemiología, Dirección Médica y CODECIAAS.

Supervisión: Dirección Médica.

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA	Para la prevención e identificación temprana de infecciones relacionadas con la atención sanitaria realiza las siguientes actividades: • Seguimiento de pacientes hospitalizados diariamente a través del censo diario electrónico; en el cual se monitorea al paciente desde el momento que ingresa y se identifica los factores de riesgo que inciden en las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). • Las Infecciones con prioridad en el departamento se destacan: EM 1,2,3,4,5,6 - o Infección de vías respiratorias - o Infección de vías urinarias - o Infección por dispositivos intravasculares invasivos - o Infección en los sitios quirúrgicos - o Enfermedades y organismos más frecuentes desde el punto de vista epidemiológico - o Organismos resistentes a múltiples fármacos - o Infecciones emergentes o recurrentes dentro de la comunidad • En cuanto al monitoreo de las enfermedades y organismos más frecuentes desde el punto de vista epidemiológico y enfermedades emergentes o recurrentes dentro de la comunidad, el departamento bajo los lineamientos establecidos por secretaria de Salud Jalisco (SSJ). • Y por último los organismos resistentes a múltiples fármacos se realiza el monitoreo a través de los antibiogramas emitidos por el laboratorio clínico sobre los cultivos realizados a los pacientes.

PROCEDIMIENTO DE ENFOQUE DEL SISTEMA

5.2	Supervisa que el personal de enfermería clasifique de manera correcta la medida precautoria correspondiente (IT-UV-18 / FT-UV-05) y vigila que el personal clínico, no clínico y familiares, respeten el tipo de aislamiento para seguridad del paciente.
5.3	Supervisa diariamente que el personal clínico realice la técnica de higiene de manos apegados a los 5 momentos como lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) (IT- UV-01/ IT-UV-04) y supervisa que el hospital cuente con los insumos suficientes (PR-UV-01
5.4	Monitorea diariamente a través de la bitácora de registro de resultados de análisis Bacteriología (FT-LA-21), los cultivos realizados de los pacientes hospitalizados y ambulatorios, con el fin de identificar de manera temprana el crecimiento de microorganismos e iniciar con las medidas precautorias correspondientes con el fin de proteger al personal clínico como no clínico, pacientes y familiares.
5.5	Revisa de manera diaria notas de evolución de pacientes con el fin de identificar de manera temprana las Infección Asociada a la Atención de Salud (IAAS) y en caso de identificarse, se hace llenado de estudio epidemiológico y se notifica a secretaria de salud. Una vez que egresa el paciente, se analiza el tipo de infección presentada al inicio o al final de su estancia hospitalaria, y si requiere cultivo de superficie en el entorno del paciente es tomada por laboratorio, con el fin de asegurar calidad y desinfección de la habitación para el siguiente paciente.

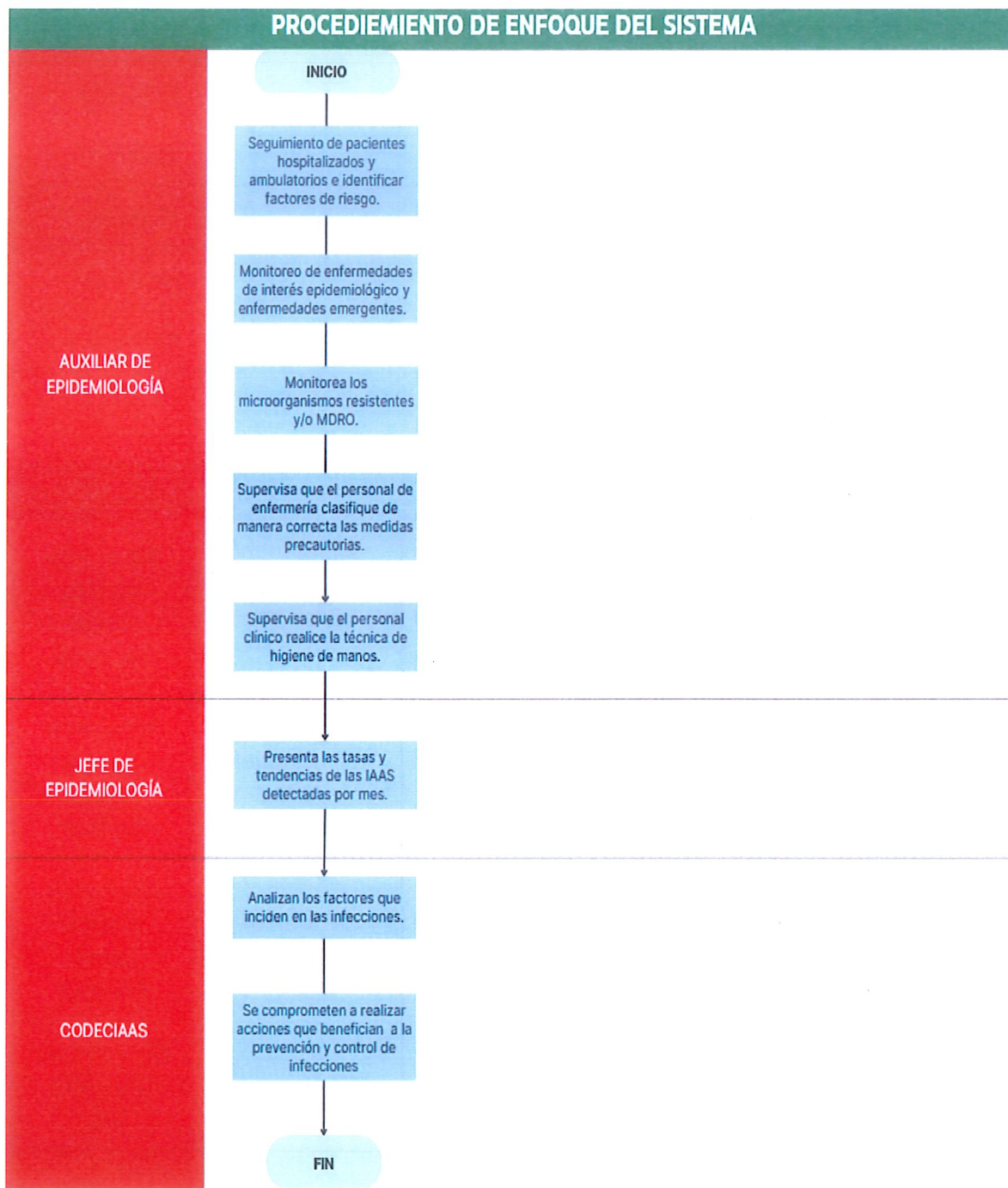
PROCEDIMIENTO DE ENFOQUE DEL SISTEMA

5.6	JEFE DE EPIDEMIOLOGÍA	El jefe del departamento a través del Comité para la Detección y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud presenta las tasas y tendencias de las infecciones detectadas por mes tomando en cuenta los siguientes factores: área, tipo de servicio y tipo de infección, con el fin de analizar donde es la causa raíz y así prevenir infecciones.
5.7	CODECIAAS	Los integrantes del comité en conjunto analizan los factores que inciden en las infecciones y se comprometen a realizar acciones que beneficien a la prevención y control de infecciones.

6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Incidencia de infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) recurrentes.	a. Capacitación continua al personal clínico de las acciones prioritarias para la prevención y control de infecciones.
b. Identificación tardía de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS).	b. Adiestramiento del personal de epidemiología para la identificación oportuna de los casos.
c. Sanciones por parte Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (COPRISJAL), por incumplimiento a los compromisos establecidos en el CODECIAAS.	d. Compromiso por parte de los jefes de departamento para realizar acciones preventivas.

7. ANEXOS. 7.1 Flujograma



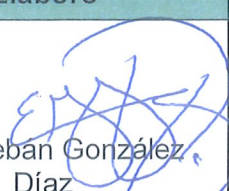
Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Supervisión de medidas precautorias	IT-UV-18
Medidas precautorias	FT-UV-05
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Higiene de manos con gel alcoholado	IT-UV-04
Abastecimiento de insumos para la higiene de manos	PR-UV-01
Bitácora de bacteriología	FT-LA-21

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	07/2021	Alta de documento	<i>Dr. Manuel Cortes Gutiérrez</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	20/09/2022	Modificación de documento	<i>Dr. Manuel Cortes</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
03	08/11/2023	Modificación de documento	<i>Dr. Manuel Cortes</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
04	26/09/2025	Actualización de procedimiento	<i>Lic. Viridiana López Fajardo</i>	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Esteban González Díaz	Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)	Jefatura de Calidad	Dirección Médica

